# Atención farmacéutica respiratoria — Modelo CMO

Informe de atención farmacéutica · SIAF-CMO Respiratorio v1.1.0 (octubre de 2026)

| | |
|---|---|
| **Fecha de evaluación** | 12/10/2026 17:21 |
| **Identificador del paciente** | RESP-P1-001 (seudonimizado) |
| **Farmacéutico/a responsable** | Farmacéutico/a de pruebas |
| **Hospital o centro** | Hospital Ficticio de Pruebas |
| **Estado de la valoración** | Definitiva |

## Resultado de estratificación: Prioridad 1

Puntuación total 37/59 · Prioridad calculada por el modelo: Prioridad 1

## SITUACIÓN CLÍNICA RELEVANTE

| | |
|---|---|
| **Patología principal** | EPOC (incluye déficit alfa-1-antitripsina, bronquitis y enfisema) |
| **Otras patologías** | Bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística |
| **Edad** | >65 años (72) (2 p) |
| **IMC** | Obesidad (IMC>=30; 31,5) (3 p) |

## VALORACIÓN CMO: VARIABLES DETERMINANTES

Puntuación por dimensiones: Demográficas 5/5 · Clínicas 12/14 · Tratamiento 13/21 · Sociosanitarias 4/16 · Utilización de servicios 3/3.

- Comorbilidad no respiratoria con medicación (excluye psiquiátrica) (3 p) — Clínicas
- Desórdenes mentales o conductuales no transitorios con medicación específica (3 p) — Clínicas
- Deterioro cognitivo-sensorial (4 p) — Clínicas
- Gravedad de la afectación o necesidad de oxigenoterapia (2 p) — Clínicas
- Tabaquismo activo (4 p) — Sociosanitarias
- >=2 ingresos y/o >=2 visitas a urgencias por descompensación respiratoria en el último año (3 p) — Utilización de servicios

## NECESIDADES FARMACOTERAPÉUTICAS IDENTIFICADAS

- Falta de adherencia a cualquier medicamento: Sí (4 p)
- Medicamentos que pueden empeorar la patología respiratoria: Sí (4 p)
- Objetivos farmacoterapéuticos: No alcanzados / inicio reciente (2 p)
- Polimedicación: seis o más principios activos: Sí (3 p)

## INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS

### Realizadas en esta consulta

Seguimiento farmacoterapéutico

- Control y seguimiento de adherencia y uso adecuado de dispositivos con registros y cuestionarios validados.

Formación y educación al paciente

- Promoción de la adherencia.

### Planificadas / pendientes

Coordinación asistencial

- Coordinación intrahospitalaria especializada (Neumología, Psiquiatría y/o Servicios Sociales).

### Recomendadas por el modelo para Prioridad 1 (no registradas como realizadas)

Seguimiento farmacoterapéutico

- Estratificación o reestratificación según criterios ordinarios o situaciones clínicas extraordinarias.
- Revisión, validación y conciliación de medicación concomitante e interacciones, ofreciendo alternativas al médico.
- Valoración multidimensional y análisis de objetivos farmacoterapéuticos (OFT).
- Monitorización y decisiones multidisciplinares en función de PROs y PREMs.

- Contacto adicional entre visitas mediante teleasistencia si el FH lo considera positivo.
- Establecimiento de OFT a corto plazo según patología respiratoria y criterio del FH.

### Formación y educación al paciente

- Identificación de no adherentes primarios/secundarios y entrevista motivacional con sistemas de fomento de adherencia.
- Fomento de paciente activo, informado y corresponsable.
- Información sobre enfermedad, tratamiento, conservación, interacciones, reacciones adversas, hábitos saludables, higiene ambiental y vacunación (gripe, neumococo, COVID, etc.).
- Formación en manejo de dispositivos, inyectores/perfusión, inhaladores, nebulizadores y ejercicios respiratorios.
- Recursos web/apps informativos, monitorización, telefarmacia y dispensación domiciliaria; en P2/P1 también a familiares/cuidadores.
- Material personalizado para paciente y/o familiares/cuidador en papel o digital.

### Coordinación asistencial

- Programas orientados a cumplir objetivos farmacoterapéuticos.
- Coordinación de próxima visita UPEFH con equipo multidisciplinar y agenda de dispensaciones.
- Sistemas personalizados de dosificación coordinados con Farmacia Comunitaria y Atención Primaria.
- Reuniones periódicas del equipo asistencial sobre indicadores de eficacia y adherencia.

## PLAN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

- Recomendación: aplicar al inicio y ante cambios; valorar cada 3–6 meses.
- Próxima valoración prevista: 15/01/2027
- Observaciones: Revisar técnica inhalatoria; derivación a deshabituación tabáquica acordada con Neumología.

**Aviso profesional**

Herramienta de apoyo profesional: no diagnóstica, no prescriptiva, no sustitutiva del juicio clínico, no producto sanitario certificado y pendiente de validación asistencial.

Basado en la metodología CMO MAPEX-SEFH: Adaptación del Modelo de Atención Farmacéutica CMO al paciente con patologías respiratorias (SEFH). https://www.sefh.es/mapex/images/modelo-CMO-al-paciente-con-patologias-respiratorias.pdf